



למה כולכך חשוב להניק כבר בחדר לידה ?

- יניקה מגרה את התכווצויות הרחם, מסייעת בפליטת השליה ועזרת לשלוט באובדן דם אצל האם.
- רפלקס היניקה של התינוק בדרך כלל חזק לאחר הלידה.
- סיפוק הרפלקס הזה "מטביע" בתינוק את ההתנהגות הביולוגית הזאת ומקדם את לימוד היניקה.

4

מתי להתחיל להניק?

◦ מומלץ להתחיל בהנקה סמוך ככל הניתן למועד הלידה במידת האפשר בחדר לידה, מייד לאחר לידת התינוק.



3

◦ הוצאה מוקדמת ותכופה של חלב מהשד ממזערת גודש בשד.

◦ הפרשת החלב מואצת, חלב רב יותר מיוצר, וצריכה מוקדמת ותכופה של חלב מהשד מפחיתה אובדן משקל אצל ילודים אחרי הלידה.

◦ הוצאה תכופה של חלב משאירה את השד מרוקן ככל האפשר ומעודדת את הסינתזה של חלב שד.



5

◦ התינוק מקבל מיד את הרכיבים האימונולוגיים של הקולוסטרם.

◦ הפריסטילטיקה של מעי התינוק זוכה לגירוי, ובכך תורמת לסילוק תוצרי הלוואי של פירוק המוגלובין. צהבת נוטה יותר להופיע במקרים של דחייה בהנקה ובפריסטילטיקה



6

קולוסטרם

- חלב מיוחד בצבע צהוב סמיך ודביק.
- דל בשומן, ועשיר בחלבונים ונוגדנים, חאת על מנת לסייע לשמור בריאות התינוק.
- מאוד קל לעיכול.
- נמוך בנפח, אך גבוה בערכים התזונתיים לרך הנולד.
- יש השפעה משלשלת בתינוק, המסייע בהפרשת העודף של בילירובין ומסייע במניעת צהבת.
- מספק כמויות גדולות של תאים חיים, שיגנו על התינוק מפני חומרים מזיקים רבים. הריכוז של גורמי חיסון הוא הרבה יותר גבוה בקולוסטרם מאשר בחלב בוגר.
- הוא מכיל כמויות גדולות של נוגדנים הנקראות אימונוגלובלינים בעיקר אימונוגלובין הנקרא IgG. (IgA) מוגן על התינוק במקומות הרגישים ביותר להיות מותקפים מחידקים, כלומר את הריירות בגרון, ריאות ומעיים.)



7

בכדי שזה יצליח ...

- כדי לאפשר התחלת הנקה והמשכה, התינוק חייב למצוץ, לבלוע ולנשום.
- על האם לרצות ולהיות מוכנה לאפשר לתינוקה לינוק
- על הסביבה לתמוך ביחידה הביולוגית



צמד אם תינוק



8



לידה

- בהיפותלמוס שלנו קיים חלק מאוד קדמוני שנקרא NEO CORTEX (NC)
- הוא בעל חשיבות מעכבת גדולה בתהליך הלידה.
- בעיקר מאחר והוא המקום שממנו מגיעים העכבות לתהליך.
- במהלך הלידה, מתקיים מפל עדין של איזון הורמונלי.
- הקשרים הכימיקלים החשובים האלה מופרשים ונשלטים ישירות על ידי מהמוח
- כאשר המוח מופרע בעבודתו, התהליך לא מסוגל להתקדם באופן טבעי. ז"א NC נכנס לפעולה

◦ זה האספקט החשוב ביותר מבחינה מעשית בפזיולוגיה של הלידה.



9

- כאשר אין הפרעות לתהליך בזמן הלידה, האישה יכולה להתנתק מעצמה ומהסביבה שלה, היא מורידה עכבות, ומתקדמת בלידה מבחינה פיזיולוגית היא מפחיתה את פעולת ה- NC שלה.

- לצורך כך האישה בלידה זקוקה לפרטיות. צריך להגן עליה מפני כל גירוי לא נחוץ של ה- NC
- שימוש בשפה, בדבור ובשאלות רציונאליות, אורות בוהקים ושימוש במוניטור כל אלה מהווים גירוי ל- NC



10

אוקסיטוצין בלידה

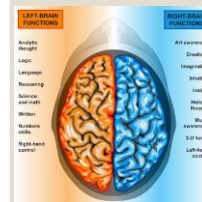
- אוקסיטוצין מופרש מאותו חלק קדום של המוח הנקרא היפותלמוס ומשתחרר לתוך מחזור הדם במצבים מסוימים.
- במהלך **לידה** נחוץ אוקסיטוצין על מנת לכווץ את הרחם.
- עד לאחרונה לא גלו עניין בנקודת שיא של אוקסיטוצין שמתרחשת מיד לאחר צאת התינוק.



12

המוח השמאלי

- שפה
- היגיון
- חשיבה ביקורתית
- הנמקה
- מספרים



11

המוח הימני

- הכרת פרצופים
- ביטוי רגשות
- מוסיקה
- קריאת רגשות
- צבע
- תמונות
- אינטואיציה
- יצירתיות



אנדורפינים

- הפרשת אוקסיטוצין בלידה מלווה בהפרשת הורמונים נוספים, אנדורפינים.
- שחרור האנדורפינים במהלך **לידה** קשור בעזרה לגוף בזמן הכאב (וכן בזמן הנאה) מדובר במערכת תגמול פיסילוגית.
- במהלך הלידה התינוק מפרש בעצמו אנדורפינים. בשעה הראשונה לאחר הלידה האימא והתינוק מוצפים בחומרים אופיאטים (מעין מורפיום טבעי, כמו סם) אשר מאפשרים להם לחוות את תהליך ההתקשרות והתלות אחד בשני.
- כשהאם מניקה רמת האנדורפינים בדמה עולה פי 20. התינוק יוצא "נשכר" מההנקה כיוון שיש אנדורפינים בחלב.



14

- קשור גם בהתנהגות אימהית אחרי הלידה ובהתקשרות עם התינוק.
- אחד השיאים של הפרשת הורמון האהבה שאישה יכולה לחוות בחיים הוא מיד לאחר **לידה**. אם הלידה לא מופרעת ע"י הורמונים סינטיטיים.
- העובר משחרר אוקסיטוצין בעצמו זה תורם כנראה להתחלת הלידה.
- במהלך ההנקה, גירוי השד על ידי התינוק מעלה את רמת האוקסיטוצין אצל האם.
- הרמות של אוקסיטוצין עולות אצל האם גם לשמע קולו של תינוקה הרעב.



13

אנדרנלין

- במהלך הצירים, לפני הלידה ממש, משתחרר אנדרנלין אצל האם והעובר.
- אחת ההשפעות של הפרשה פתאומית זו של אנדרנלין היא שהאם ערנית ביותר בשעת הלידה.
- ההשפעה של האדרנלין על העובר היא שהוא ערני בלידה עם עיניים פתוחות לרווחה ואישונים מורחבים.
- אמהות נפעמות מלהסתכל על תינוקן שרק נולד. נראה שלקשר עין המידי בזמן הלידה יש חלק ביצירת הקשר אימא-תינוק.



15

- שמבינים את המודל הפיזיולוגי של הלידה, קל יותר להבין שסטיות מתהליך זה ע"י שימוש בחומרים מבחוץ במקום ההפרשה הטבעית של הגוף עלולים לשבש את המהלך ולפגוע ברצף האירועים היוצרים את התהליך השלם.



16

השפעת הלידה על הנקה

לידה	עכוב בייצור החלב
ווגינלית ספונטנית	16%
ווגינלית התערבותית	42%
קיסרי מתוכנן	27%
קיסרי חרום	56%



18

° באיזה אופן עלולות התערבויות טכנולוגיות בלידה לשבש את התהליך באופן כללי ואילו השפעות יש להן על תהליך ההנקה בפרט?



17

- ° תינוק שאמו קיבלה תרופות בלידה מתקשה להפעיל את הרפלקסים שלו.
- ° הוא מנמנם לא מסוגל לפתוח את עיניו.
- ° הזמן הקריטי למפגש הראשוני אם-תינוק מוחמץ.
- ° תינוק כזה בד"כ מנומנם ולא יונק הרבה שעות אחרי הלידה.
- ° האם מתוסכלת מהתינוק הישנוני שלה שלא "רוצה" לינוק.
- ° אם ההנקה לא מתחילה בבית חולים, אזי הקשיים והבעיות שהאם תפגוש תוך 72 - 48 שעות הם רבים.



20

- ° התינוק שנולד בזמן ובמועד צריך לעשות תהליך של הסתגלות לחיים מחוץ לרחם.
- ° הטבע נותן לו מערכת מתוככמת של הסתגלות- רפלקסים הקשורים בהזנה ובמוטוריקה.
- ° עם הלידה, כאשר התינוק נמצא עם אמו במגע עור לעור, הוא מסוגל להגיע בעצמו לפטמה ולהתחיל לינוק בתוך פרק זמן של כשעה.
- ° הקולוסטרום שנמצא בשד כבר משבוע 20 להריון מחכה לתינוק.
- ° הערנות המיוחדת של האם והתינוק אחרי הלידה מסייעת בידיהם לבצע את החיבור וההתקשרות.



19



◦ הבדל חשוב נוסף הוא האופן הפעמתי שבו מופרש האוקסיטוצין ע"י המח לעומת ההחדרה הרציפה של פיטוצין לגוף.
◦ הבדל זה מסביר את ההתכווצויות הרחמיות החריפות האופייניות לאחר החדרת פיטוצין. דפוס התכווצויות כזה יוצר לחץ מתמשך על כלי דם בחבל הטבור ועלול לגרום לירידה בדופק העוברי.



22

◦ אוקסיטוצין הניתן באופן מלאכותי (קרי פיטוצין) איננו מגיע למח עקב חסימתו על ידי מנגנון ההגנה של המח
BLOOD BRAIN BARRIER
◦ בנוסף, אספקת ההורמון מבחוץ עוצרת את שחרורו באופן טבעי על ידי המח. כתוצאה מכך משתבשת במידה רבה השפעתו ההתנהגותית של האוקסיטוצין, קרי, ההתקשרות הראשונית בין האם לתינוק וזום ההנקה מעכבים.



21

◦ מכיוון שחל שיבוש בהפרשת אוקסיטוצין טבעי בגוף האישה בזמן הלידה, יכול להיות עיכוב בשחרור אוקסיטוצין לאחר הלידה.



24

שימוש בפיטוצין בלידה

◦ עליה בשכיחות הניתוחים הקיסריים והלידות המכשירניות בלידות המתחילות בהשראת לידה ע"י פיטוצין.
◦ תינוק שנולד בלידה כזאת מתקשה בד"כ לקיים את אותו מפגש מיוחד עם אימו לאחר הלידה.
◦ בנוסף, אחרי לידה קשה יש סבירות רבה להפרדה בין האם והתינוק המחריפה עוד יותר את השיבוש ביצירת הקשר הראשוני הייחודי ביניהם.



23



השפעת שיכוך כאבים תרופתי בלידה על ההנקה

- תינוקות שאינם קבלה תרופות לשיכוך כאבים בלידה (אפידורל, טשטוש או שילוב של שניהם) מתקשים לבצע את סידרת הפעולות הדרושות לייחום ההנקה.
- קשה להם "להתלבש" על השד (LATCH) קשה להם להתמיד במציצה לאחר ההתלבשות על השד ולשמור על הוואקום.
- לעיתים המציצה שלהם מאד לא מאורגנת וללא תאום עם מערכת הנשימה, דבר הגורם להשתנקויות.



25

- רפלקס מציצה משובש ולשון שלא עובדת נכון בפה גורמים להקטנת כמות החלב המגיעה לתינוק.
- תינוקות כאלה הם בדרך כלל ישנוניים ולא מראים סמני רצון לנינוק.
- התהליך שנפגע בתחילתו גורם לכך שתינוקות אלה עולים פחות במשקל ומאבדים יותר ממשקל לידתם בשבוע הראשון.
- לאמהות שלהם יש סיכוי ליותר בעיות בהנקה כמו פצעים בפיטמה, גודש וייצור מועט של חלב כתוצאה מריקון לא יעיל.



26

אפידורל בלידה

- אפידורל זו שיטת אלחוש אזורית המשתמשת בחומרים של הרדמה מקומית עם או בלי חומרים נרקוטיים על מנת להקל כאב בלידה.
- אפידורל יכול להשפיע על ההנקה דרך השפעת התרופות ישירות על העובר וגם דרך השפעות הלואי הרבות שיש לו על מהלך הלידה.
- החומר מגיע במהירות מהחלל האפידורלי למחזור הדם של האם, לאחר מכן עובר את השיליה כך שריכוז מדיד נוכח במחזור הדם העוברי תוך כעשר דקות.



27

- השילוב של חומרים נרקוטיים, כמו פנטניל, באלחוש האפידורלי מעלה את שכיחות ירידות הדופק העוברי ואת הירידות בלחץ הדם האימהי שמהווים גורמים לניתוחים קיסריים.
- אפידורל קשור בעליה בלידות מכשירניות עקב האטה בירידת התינוק באגן וכניסתו לתעלת הלידה.



28



לידת מכשירניות

- סכנת פגיעה פיזית בתעלת הלידה
- סכנה לפגיעה עצבית מוטורית ביילוד
- סטרס וכאב לאם ולילוד
- פצע באזור הראש או הפנים במגבירים את הסיכוי לצהבת פיזיולוגית
- חוסר סימטריה של הפנים
- פגיעה במערכת הקרנאלית



30

- אפידורל גורם לעליה בחום אימהי בלידה וכתוצאה מכך התינוק נולד עם חום.
- תופעה זו הקרויה חום אפידורלי(שלא על רקע של זיהום) גורמת לתינוק לעבור בדיקות דם ולפעמים לקבל אנטיביוטיקה בתחילת החיים עד שמתקבלות תוצאות הבדיקה מהמעבדה.
- כל הפרוצדורות הללו פוגעות בתהליך הפיסיולוגי שאמור להתרחש עם הלידה, ולהתקשרות אם-תינוק.



29

הסיבות לניתוח אלקטיבי(מתוכנן)

- אי התאמה בין ראש העובר לאגן האם
- סיבוכים של סכרת הריונית לא מאוזנת
- עובר במנח עכז/רוחבי-מצג מצח/פנים.
- הריון מרובה עוברים .
- יולדת שעברה 2 ניתוחים קיסריים קודמים או ניתוח קיסרי בחתך אורכי.
- משקל היולדת



32

ניתוח קיסרי

- הניתוח הנפוץ ביותר במדינות המתועשות בעולם
- לעיתים יבצע תחת הרדמה כללית



31



ניתוח חרום

- יולדת בלידה שאינה מתקדמת
- מצוקה עוברית כגון: ירידת דופק משמעותית
- מים מקוניאליים
- צניחה של חבל הטבור
- הפרדות שליה
- רעלת הריון



34

סיבות אימהיות לניתוח

- מום מולד ברחם
- שלית פתח
- מחלות של האם אשר יגרמו נזק לעובר אם יעבור בתעלת הלידה כגון: הרפס, HIV, Toxoplasma
- נגיפים אלו ואחרים אשר היולדת נושאת ונמצאים באזור הנרתיק ואיבר המין.
- בחירה של האם /בני המשפחה



33

סכרת הריונית

- סוכרת הריונית מופיעה ומלווה כ- 5%-10% מכלל הנשים ההרות וסוכרת קדם הריונית (מסוג 1 או 2) כ-1% מכלל ההריונות. סוכרת יכולה לגרום לסיבוכים אימהיים ועובריים בשכיחות הרבה יותר גבוהה מהצפוי בהריונות רגילים.



36

רעלת הריון

- לחץ דם גבוה אחר השבוע ה-20 לעיתים מלווה בחלבון בשתן
- 5%-3% מהריוניות, נפוצ יותר אצל סוכרתיות
- לעיתים כאשר יש החמרה יטופלו אימהות עם מגנזיום אשר מותר בהנקה
- ההנקה תתאפשר בהתאם למצב האם והתינוק
- אם היונק לא יונק יש לאפשר הוצאת חלב מהשד שעות ספורות לאחר לידה



35



סיבוכים עובריים:

- שכיחות גבוהה יותר של הפלות עצמוניות מוקדמות, מומים מולדים,
- האצה בגדילה התוך רחמית – מקרחומיה,
- האטה בהבשלת הריאות.
- אחר הלידה תינוק שנולד לאם סוכרתית נמצא בסיכון גבוה יותר לפתח צהבת ילודים.



38

הסיבוכים האימהיים הנפוצים עקב סוכרת הריונית

- רמות סוכר גבוהות או נמוכות מהנורמה (היפרגליקמיה והיפוגליקמיה),
- רעלת הריון,
- מחלות יתר לחץ דם,
- ריבוי מי שפיר,
- זיהומים חזרים בדרכי השתן ואיברי המין,
- לידות טראומטיות (שכיחות גבוהה יותר של לידות מכשירניות וניתוחים קיסריים).



37

- ההנקה מפחיתה את הסיכוי של התינוק היונק לחלות בעתיד בסוכרת מסוג 1, שהיא סוכרת שיש לה גורמי סיכון גנטיים.
- אימהות מניקות מדווחות על מצב בריאותי טוב יותר במהלך ההנקה.
- עם זאת נשים סוכרתיות מתקשות יותר להיניק בימים הראשונים לאחר הלידה. הורמון האינסולין נחשב כהורמון שמתחרה על הנקה, לכן יכול להיות עיקוב של יומיים שלושה של "כניסת החלב" - המעבר מקולוסטרם לחלב אם בשל.



40

- נשים שפתחו סוכרת בזמן ההריון נמצאות בסיכון גבוה יותר לפתח סוכרת בעתיד. ישנם מחקרים שמעידים על כך שנשים סוכרתיות שהניקו הפחיתו את הסיכוי להתפתחות סוכרת מאוחרת יותר.
- הנקה מורידה את רמות הסטרס בגוף. אימהות מניקות נזקקות פחות לתוספת של אינסולין.



39



שאריות שליה RETAINED PLACENTA

- לעיתים מתגלה רק לאחר היציאה מבית החולים
- דימום ממושך לאחר לידה
- עיכוב בייצור החלב : אמהות לא יחושו מלאות ואף ימשיכו לייצר קולוסטרום
- חוסר מלאות בשד ללא דימום מוגבר
- הגברה משמעותית בכמויות החלב לאחר הוצאת השליה



42

חתך חייץ

- בבתי חולים מסוימים נעשה לרוב בצורה שגרתית בלידה מכשירנית
- סיבוכים אפשריים : דימום , הארכת החתך
- כאבים עזים עד כדי הפרעה בשחרור רפלקס החלב
- כאב לשבת .



41

Sheehan syndrome

- איבוד דם שחורג מהטווח הנורמלי ללידת נרתיקית (עד 500 סמ"ק) או הלידה בנייתוח קיסרי (עד 1,000 סמ"ק) יכול למקם אם בסיכון של ייצור חלב נמוך.
- דימום משמעותי במהלך או לאחר לידה – לחץ הדם יכול לרדת כל כך נמוך – אין זרימת דם לבלוטת יותרת המוח – זה יכול לגרום לחלק או לכל התאים בבלוטת יותרת המוח להפסיק לפעול באופן נורמלי.
- איבוד דם יכול גם ליצור אנמיה, שהוא גורם סיכון נוסף לייצור חלב נמוך.



44

דימום לאחר לידה

- הסיכון הנפוץ ביותר 5% מהלידות
- יתכן איבוד דם משמעותי
- בקבלת פיתוץ ישר לווריד יש חשש להשפעה על ייצור החלב
- לחץ דם נמוך
- אימא מותשת ותתכן חולשה עד 12 שבועות אחרי הלידה עד לחידוש כדוריות הדם האדומות .



43

שאיבת נחלים מאף

- הפרעה אפשרית נוספת היא שאיבה של אף היילוד אחרי הלידה. השאיבה נוטה לגרום ליילוד לסבול מבצקת של האף ומ"גודש". מכיוון שנתיב האוויר של התינוק חסום במידת מה, התינוק לא יונק היטב עד שהנפוחות יורדת. שאיבה של פה התינוק עלולה להוביל לקשיים בהנקה כי פיו או גרונו של התינוק עלולים להיות רגישים



46

זיהום

- יכול להיות מקומי (דרכי השתן , ניתוח) או להתפשט
- דלקת בקרום הרחם
- **Endometriosis** אנדומטריטיס)
- עליה בחום היולדת
- שימוש באנטיביוטיקה
- אשפוזים



45

חשיבות ביות מלא

- הימצאותו של התינוק לצד אמו באופן קבוע (ביות מלא) מאפשרת לשניהם ללמוד את יסודות ההנקה ולהתנסות בה. הביות מאפשר הנקה על פי דרישה, והוכח כי הוא מגביר את שיעור ההצלחה של ההנקה.



48

הפרדה של אם והתינוק

- סימני מצוקה ובכי
- פעילות מוגברת של חיפש אחרי האימא
- ייאוש- התינוק נסוג תוך כדי ירידת קצב הלב
- וחום הגוף המלווים בעיה של הורמוני הסטרס



47

- תדירות ההנקה עולה כשהאם והתינוק חולקים חדר, ומתן תוספות עם חלופות לחלב אם (תמ"ל) קורים פחות
- אימהות לא בהכרח ישנות יותר כאשר התינוק נלקח למחלקת ילדים בלילה.
- התנהלות וחוקי בתי החולים משפיעה על התבססות ויעילות ההנקה.
- מגע עור לעור והנקה מספקים חוסר רגישות לכאב בזמן הליכים רפואיים כואבים.

אימהות ותינוקות צריכים לשהות ביחד



איך עושים את זה ?

- יש לייבש את התינוק ולשים אותו על האם.
- אין להאיץ בתינוק לעשות שום דבר.
- אין לנסות לעזור לתינוק לינוק. האם יכולה כמוהן לנסות לעזור לתינוק ואסור להניא אותה מכך. יש לעזור במנוחה את האם והתינוק כדי שיוכלו ליהנות זה מחברת זה
- אך אין להשאיר את האם והתינוק לבדם. (במיוחד אם האם קיבלה תרופות וחשוב שלא רק האב, אלא גם אחות, מיילדת, דולה או רופא יהיו איתם – לעתים יש תינוקות שזקוקים לטיפול רפואי וצריך שיהיה שם מישור "לכל מקרה").
- טיפות העיניים והזרקת ויטמין K יכולים לחכות שתיים.

מגע עור אל עור



- סיכויים גבוהים להיצמדוּת טובה
- חום גוף יציב ותקין יותר
- קצב לב ולחץ דם יציבים ותקינים יותר
- רמות גבוהות יותר של סוכר בדם
- מאפשר לתינוק לקבל אליו את אותם החיידקים שיש אצל האם
- פחות סיכוי לבכי
- יותר סיכויים להנקה בלעדית למשך תקופה ארוכה יותר

- תינוקות נכנסים למצבים שונים רבים במהלך יום טיפוס אחד.
- שישה מצבים:
- שני סוגי שינה (שינה שקטה ושינה פעילה),
- שני מצבי עיירות (עיירות שקטה ועיירות פעילה)
- ושני מצבי מצוקה (עצבנות ובכי).



54

דפוסי השינה של ילודים ביום הראשון

- | | |
|--|---|
| <p>הזמן</p> <p>לידה - שעתיים</p> <p>שעתיים - 20 שעות פלוס</p> <p>20-24 שעות</p> | <p>מצב התינוק</p> <p>◦ ערני</p> <p>◦ שינה קלה ועמוקה</p> <p>◦ ערנות מוגברת</p> |
|--|---|



53



56

QUIET SLEEP שינה שקטה

- המכונה גם "שינה עמוקה",
- התינוק שוכב בלי לנוע ונושם נשימות איטיות וסדירות מתרחשת כאשר התינוק הוא במצב הכי רגוע.
- עפעפיו של התינוק יישארו סגורים, יחסית לא מגיב לרעשים מבחוץ.
- כמובן שהוא עשוי להתעורר, אבל רק במעט.
- ביילוד קיים לסירוגין מעבר בין שינה שקטה ופעילה בכל 30 דקות



55



שינה פעילה ACTIVE SLEEP

- במהלך "שינה פעילה", רעשים פתאומיים יכולים להקפיץ את התינוק
- התינוק נע לעיתים קרובות, מניע את זרועותיו ורגליו, מקמט את פניו, נושם נשימות מהירות יותר וסדירות פחות מאשר שינה שקטה ולפעמים נראות תנועות מהירות של עיניים מאחורי עפעפיים סגורים.
- השינה הפעילה של תינוקות דומה לשנת REM (rapid eye movement) אצל בוגרים שגם בה יש תנועות עיניים מהירות.



התראה שקטה QUIET ALERT

- יילודים במצב "התראה שקטה" עושה תנועות קטנות ונדירות, אם בכלל. העיניים פתוחות לרווחה במודעות מבט ממוקד, יכול לפנות לקול ואפילו מתחילים לחקות ביטויי פנים.
- אולי נראה מאופק במצב הזה, אבל הוא בעצם עסוק בלמידה על העולם סביבו.





התראה פעילה - ACTIVE ALERT

◦ במצב זה היילודים מגיעים לשיא של תנועות. הם מותחים את הזרועות ובעט ברגליים. תנועות אלו נעשו מתוך מטרה לחיזוק קשר שבין המוח והשרירים. עיניו של התינוק לעתים קרובות מתרוצצות והוא עשוי לעשות קולות קטנים



בכי פעיל - ACTIVE CRYING

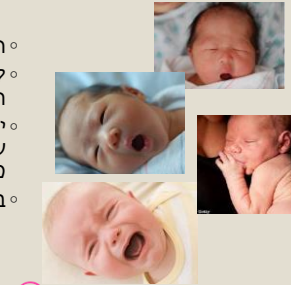
◦ התנועות של היילוד עוברות מקצבית לתוהו ובוהו. עיניו נעצמות מופעים פיתולי פנים חרועותיו, ומכה עם הרגליים מסביב.
◦ התינוק בוכה כשהוא מרגיש רעב, אי נוחות, תסכול או בדידות.



אך אני אדע אם התינוק רעב ?

- תנועות מציצה בפיו
- לגשש בפיו ולחפש את השד
- יכניס אל פיו כל מה שנמצא בסביבתו-אגרוף כתף, אצבעות וכו' ...
- בכי

◦ בכי הוא סימן מאוחר לרעב !!!!



תנומה DROWSINESS

- נמנום מתרחש כמעבר בין ההתראה ומצבי שינה. כתינוקות מתעוררים או נרדמים, הם נכנסים למצב הרדום.
- התינוק יכול לעשות כמה תנועות גוף, כגון מתיחה, כמו גם מגוון רחב של הבעות פן - מזועף למחייך לפהק. עפעפיו תמיד נופלים במצב זה, עם זאת, ועיניו עם מבט מזוגג, לא ממוקד.



כמה זמן יש להניק? האם להניק משני הצדדים בכל ארוחה?

- הנקה על פי דרישה
- לא להסתכל על השעון -משך ההנקה אישי ותלוי בתינוק בלבד.
- רצוי להציע לתינוק את שני השדיים בכל ארוחה הניקי בצד הראשון עד שהתינוק נראה שבע, לפני שאת מציעה לו את הצד השני.
- הניקי כאשר התינוק מראה סממני רעב מוקדמים או בערך כל 1-3 שעות.
- הערה: יש תינוקות השבעים מצד אחד בלבד. בעוד אחרים ינקו משני צדדים בכל האכלה.





התינוק יונק בצורה אופיינית

◦ תראו הפסקה בתנועת הסנטר שלו אחרי שהוא פותח את פיו עד הסוף ולפני שהוא סוגר אותו, כך שמציצה אחת היא "פה פתוח רחב" < הפסקה < פה סגור".



כיצד אדע אם התינוק ינק מספיק?

- 8-12 האכלות במהלך 24 שעות. הן דבר אופייני, אך תדירות יכולה להשתנות.
- יש תינוקות אשר ינקו הנקות תכופות (האכלה כל שעה למשך 2-6 שעות ואז ישנו שינה ארוכה יותר), וישנם אחרים שיאכלו כל 2-3 שעות יום ולילה.
- בממוצע, תינוקות יאכלו 15-20 דקות מכל שד בארוחה. חלק מהתינוקות יאכלו בזמן ארוך יותר ואחרים יסתפקו בשד אחד בלבד.
- תינוקות ישנוניים צריכים להעיר לאכלה, עד אשר דפוס העלייה במשקל שלהם יתייצב.

- ישנם ילודים שיש להם יציאה אחרי כל הנקה או אף יותר- זה נורמלי לחלוטין.
- הצואה התקינה של תינוק יונק היא רכה.
- הסברה כי לאחר 4-6 שבועות, יש תינוקות עם פחות יציאות, לעתים פעם 7-10 ימים זה תקין – אז לא !!!
- כל עוד התינוק עולה היטב במשקל, זה תקין.

חיתולים עם צואה:

- מהיום הרביעי לאחר הלידה עליו לייצר לפחות 6-8 חיתולים ספוגים מדי 24 שעות.
- בארבעת עד ששת השבועות הראשונים לחייו, יש לצפות ל-4-3+ יציאות בגודל של 2.5 ס"מ או יותר

יום 2-4



יום ראשון



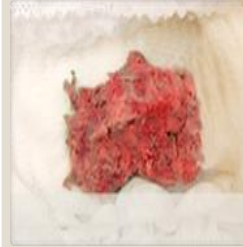


ירוק כהה



- אצל חלק מהתינוקות, החיידקים שבמעיים מגיבים לתוספת ברזל שניתנת לתינוק, מה שגורם לצבע הקקי להיות ירוק כהה או לפעמים אפילו ירוק-שחור

אדום-ורדרד



- כשהתינוק מתחיל לאכול אוכל מוצק, הקקי יכול לשנות את מרקמו וצבעו אפילו אחרי כל ארוחה.
- גם תרופות יכולות להפוך את צבע הקקי ללא שגרת.
- בדקו מה אוכל התינוק כדי לראות אם יש קשר ישיר בין מה שאכל לצבע הקקי. מאכלים שיכולים להשפיע על צבע קקי הם: גזר (צבע כתום) ותרד (ירוק)
- אם צבע הקקי אדום ללא סיבה הנראית לעין (כמו צבע אדום אחרי ממתק, ג'לי אדום, סלק), גשו לרופא.

לבן וגירי



- קקי בגוון לבן עלול להצביע על בעיה בכבד או בכיס המרה. המרה היא חלק ממיצי העיכול המיוצרת בכבד ומאוחסנת בכיס המרה והיא הופכת באופן טבעי את הקקי לחום. במידה שהכבד של התינוק לא מייצר מרה, או שהמרה חסומה, הקקי יהיה לבן.

יבש, חום וקשה



- קקי קשה דמוי גללים יכול להעיד על עצירות. עצירות מקרית היא נורמלית, במיוחד בהזנה בתרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) או כשהתינוק עובר לאוכל מוצק.
- זה יכול להצביע על כך שהתינוק אינו שותה מספיק נוזלים, או שהוא מאבד הרבה נוזלים (כשחם, או עקב מחלה).
- ייתכן דם על פני שטח הצואה, כאשר קקי יוצר קרעים קטנים ברקמות שסיבי פי הטבעת.
- אם התינוק קטן עדיין (עד גיל 6 חודשים), יש להיוועץ עם הרופא. יועצת הנקה ייתכן ויש בעיה בהנקה
- במידה שהתינוק אוכל אוכל מוצק, תנו לו מזון עשיר בסיבים, כמו פירות וירקות ודגנים מלאים.

עלייה במשקל:

- הירידה במשקל לאחר הלידה אינה צריכה להיות יותר מ- 7 אחוזים.
- על התינוק להפסיק לרדת במשקלו ביום הרביעי, ולחזור למשקל הלידה שלו בין היום ה-10 ל-14 לאחר הלידה.
- תינוק בממוצע עולה 140-170 גרם לשבוע
- יש לצפות לעליה במשקל של 20-35 גרם ביום, בשלושה חודשים הראשונים.
- עד גיל שישה חודשים עליו להכפיל את משקל הלידה שלו, ועד גיל שנה עליו לשלש אותו.



86

גשו לרופא במידה שיש:



- דם או ריר בצואה
- חום
- הקאות
- סירוב לאכול
- חוסר נינוחות
- ירידה בפעילות
- ירידה בכמות מתן השתן או שתן כהה



85

הדברים הבאים הינם נורמליים:

- הנקות תדירות ו/או ממושכות.
- שינוי דפוס היניקה מיום ליום.
- הנקה במקבץ cluster feeding (הנקה מאד תכופה או הנקה כל הזמן) למשך מספר שעות – בדרך כלל בערב – בכל יום. זה גם הזמן בו תינוקות נוטים לבכות יותר בחודשי החיים הראשונים.
- קפיצות גדילה, בהן התינוק יונק יותר מהרגיל במשך מספר ימים ולעיתים בוכה יותר מהרגיל. בדרך-כלל קפיצות גדילה מתרחשות בגילאים 7-10 ימים, 2-3 שבועות ו-4-6 שבועות.



88

סימנים שאמורים להדליק נורה אדומה

- כשהתינוק אינו מייצר לפחות 4-6 חיתולים ספוגים מהיום הרביעי לחייו ואילך.
- כשהתינוק ישן כל היום.
- כשהתינוק בוכה כל היום.
- כשהתינוק לעולם אינו נראה מרוצה אחרי הנקות.
- כשהתינוק לא חוזר למשקל הלידה בגיל שבועיים.
- כשיש כאבים בשיניים



87

בכי התינוק:

- אין להתעלם משום בכי
- בכי יכול להיות סימן של רעב או למצוקה – אם התינוק אינו מצביע על סימני רעב, ההורים יכולים להציע חלופות אחרות להרגעה לפני מתן שד.
- התינוק יכול לחוות כאב
- הנקה יכולה לשמש כמשכך כאבים.
- משכך כאבים הניתן לאם במהלך הלידה עלול להפריע לחיפוש השד הספונטאני ועל התנהגות ההנקה ויכול להגביר את חום התינוק והבכי.



90

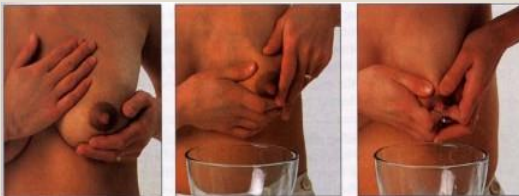
זה לא מעיד על כך שאין לי חלב

- העדר תחושת מלאות בחזה
- התינוק ישן בלילה
- התינוק בוכה אחרי הנקה
- התינוק יונק לעתים תכופות ו/או זמן רב
- "אני יכולה לשאוב רק 15 מיליליטר חלב"



89

שאיבה ידנית



92

האכלה בכפית



91



תודה



94

חיתולים עם שתן:

- יש לצפות ל-6-5+ חיתולים עם שתן ביממה.
- לאחר 6 שבועות, כמויות החיתולים הרטובים יורדת ל-4-5 ביממה אך כמויות השתן בכל חיתול עולה ל-60-90 מ"ל כששלפוחית השתן של התינוק גדלה.
- שתן ראשון קורה בד"כ 8 שעות מזמן הלידה.



93